

Blutdruck: ideal ist unter 120.

Kaum ein Wert lässt sich mit dem eigenen Alltag so stark verändern. Vorne ordnest du deine Werte ein, hinten steht, was du tun kannst und wann Medikamente dazukommen.

1 RICHTIG MESSEN



Ruhe

5 Minuten sitzen,
Rücken angelehnt



Herzhöhe

Manschette am
Oberarm, Arm
aufgelegt



Stille

nicht sprechen,
Beine
nebeneinander



Zweimal

im Abstand von
einer Minute



Uhrzeit

morgens vor
Frühstück und
Tabletten, abends
vor dem Essen



Eine Woche

der Durchschnitt
zählt, nicht der
Einzelwert

2 DEINE WERTE EINORDNEN

	nicht erhöht	erhöht	Bluthochdruck
in der Praxis	unter 120/70	120–139 / 70–89	ab 140/90
zu Hause, Wochenmittel	unter 120/70	120–134 / 70–84	ab 135/85

Dein Wochenmittel zu Hause

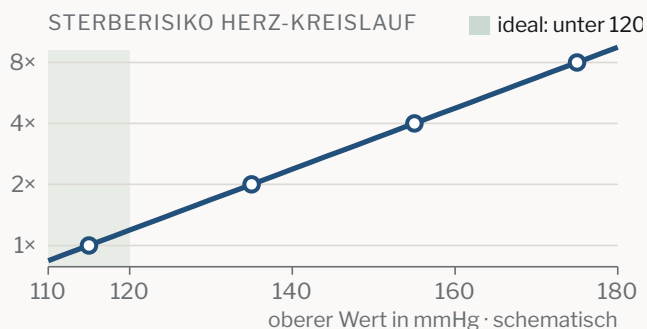
 / mmHg

Dein Wert in der Praxis

 / mmHg

**Ab 180/110 am selben Tag abklären;
mit Brustschmerz, Atemnot oder
Sprachstörung: 112.**

3 WARUM JEDER PUNKT ZÄHLT



Je 20 mmHg mehr verdoppelt sich das Risiko, an Herzinfarkt oder Schlaganfall zu sterben, schon ab etwa 115. Eine Schwelle, ab der es plötzlich gefährlich wird, gibt es nicht.

–20 %

schwere Herz-Kreislauf-
Ereignisse je 10 mmHg
weniger

–27 %

Schlaganfälle je 10 mmHg
weniger

4 WAS BEI BLUTHOCHDRUCK ZUSÄTZLICH GEPRÜFT WIRD



Schäden an den Organen

- **Herz:** EKG, bei Auffälligkeiten Ultraschall
- **Niere:** Filterleistung (eGFR) und Eiweiß im Urin
- **Gehirn:** Gedächtnis erfragen, MRT nur bei Beschwerden
- **Augen:** Netzhaut, v. a. bei Diabetes oder sehr hohen Werten

Schäden entstehen oft Jahre, bevor man etwas merkt.
Wer schon einen hat, wird früher behandelt.



Steckt eine andere Ursache dahinter?

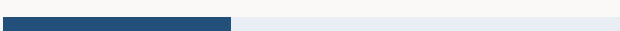
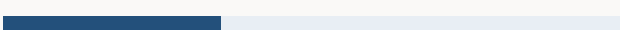
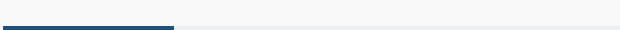
- Beginn **vor dem 40. Lebensjahr**
- **plötzlicher Anstieg** oder zu hoch **trotz drei Medikamenten**
- lautes **Schnarchen mit Atemaussetzern**

Häufigste behandelbare Ursachen sind das Nebennierenhormon Aldosteron und nächtliche Atemaussetzer.

Gerne suche ich mit dir nach der Ursache.

5 WAS DU SELBST TUN KANNST

Senkung des oberen Werts in mmHg, im Mittel der Studien. Kombiniert wirkt mehr, aber nicht einfach die Summe.

	DASH-Kost mit wenig Salz bei Bluthochdruck		-11,5
	Isometrisches Training z. B. Wandsitz		-8,2
	Ausdauer plus Kraft kombiniert		-6,0
	5 kg weniger Gewicht je Kilo etwa 1 mmHg		-4,4
	Salz um 4 bis 5 g senken pro Tag		-4,2
	Weniger Alkohol bei regelmäßigem Trinken		-3,3

**5 g**Salz pro Tag,
höchstens**Kalium**viel Gemüse, Obst,
Hülsenfrüchte**150 min**Bewegung pro
Woche, dazu 2–3×
Kraft**94 / 80 cm**Taille Männer /
Frauen, höchstens**wenig**Alkohol, am besten
keinen

ESC-Leitlinie 2024. Kaliumsalz statt Kochsalz senkte Schlaganfälle um 14 %; bei Nierenerkrankung oder Tabletten, die Kalium erhöhen, vorher abklären.

6 WANN MEDIKAMENTE DAZUKOMMEN**ab 140/90**→ Medikament **und** Lebensstil zugleich, meist zwei Wirkstoffe niedrig dosiert in einer Tablette.**130–139 und hohes Risiko**

Drei Monate Lebensstil, dann Medikament, wenn weiter ab 130/80. Hohes Risiko: Herz-Kreislauf-Erkrankung, Diabetes, Nierenerkrankung, Organschaden, SCORE2 ab 10 %.

120–139, kein hohes Risiko

→ Lebensstil, kein Medikament. Einmal im Jahr kontrollieren.

Ziel mit BehandlungOberer Wert **120 bis 129**, wenn gut vertragen; ab 85 oder bei Gebrechlichkeit individuell festgelegt.**7 KONTROLLE**

Nach drei Monaten eine Messwoche wiederholen; mit Medikament bis zum Ziel öfter, danach jährlich.

	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
morgens							
abends							

8 DEINE ERSTEN SCHRITTE

- ☐ Eine Woche richtig messen, Mittel eintragen
- ☐ Salz halbieren: Brot, Wurst, Käse, Fertiggerichte prüfen
- ☐ Wandsitz 4 × 2 Minuten, dreimal pro Woche
- ☐ _____

9 PASSENDE HANDOUTS**Ernährung**

DASH und Salz

**Krafttraining**

mit Wandsitz

**Ausdauer**

Zonen und Intervalle

**Schlaf**

Atemaussetzer

**Fragen? Vereinbare einen Termin bei mir.**Praxis KardioPro · Im Neuen Stahlhof · Breite Straße 69 · 40213 Düsseldorf
0211 54 55 66 46 · bruno@kardio.pro · kardio.pro

Quellen: McEvoy JW et al., 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension, Eur Heart J 2024 · Lewington S et al., Lancet 2002 · Ettehad D et al., Lancet 2016 · Sacks FM et al., NEJM 2001 · Edwards JJ et al., Br J Sports Med 2023 · Neter JE et al., Hypertension 2003 · He FJ et al., BMJ 2013 · Xin X et al., Hypertension 2001 · Neal B et al., NEJM 2021.